

Chap5-21. 구강/치과 매개체와 소화불량 (Whitman)

Oral/Dental Mediators of Maldigestion and Malabsorption (Whitman) | AFMCP Chap5

1. 소화는 구강에서 시작된다

"장 건강은 곧 구강 건강이고, 구강 건강은 곧 장 건강입니다." 소화의 시작점인 구강의 상태는 장 전체 기능에 직접적인 영향을 미칩니다. 치과 전문의 Whitman 박사는 임상 의들이 장 건강 평가 시 반드시 구강 건강을 함께 평가해야 한다고 강조합니다.

2. 소화불량에 영향을 미치는 구강/치과 요인

1) 치아 교합과 저작 능력

- 결손치: 치아가 없으면 저작 효율이 크게 감소
- 부정교합: 치아가 제대로 맞지 않으면 완전한 씹기 불가
- 치아 혼잡(crowding): 음식 저작 방해
- 손상된 치과 치료: 통증으로 씹기 회피, 부드러운 음식 위주 섭취

2) 타액 부족 (구강건조증, Xerostomia)

타액은 소화의 "황금 묘약"입니다. 타액에는 아밀라아제(탄수화물 분해), 리파아제(지방 분해 시작), 뮤신(음식 점화제), 항균 단백질(IgA, 리소자임)이 포함되어 있습니다.

- 타액 부족 원인: 약물(항히스타민제, 항우울제, 이뇨제, 베타차단제 등), 자가면역 질환(쇼그렌 증후군), 방사선 치료, 탈수
- 타액 부족의 결과: 씹기/삼키기 어려움, 위산 완충 능력 감소, 세균 증식, 충치 위험 증가

3) 구강 근기능 장애 및 구조적 문제

- 설소대 단축증(tongue-tie): 혀 움직임 제한으로 저작 효율 감소
- 근육 긴장도 이상: 저작근 기능 저하
- 턱관절 장애(TMJ): 통증으로 씹기 어려움

4) 구강 호흡

구강 호흡은 저작 패턴에 직접 영향을 미칩니다. 코가 막힌 상태에서는 음식을 충분히 씹지 못하고 빠르게 삼키게 됩니다("으깨고, 으깨고, 삼키기" 패턴). 원인: 비갑개 염증, 비중격만곡, 아데노이드, 만성 알레르기.

임상 팁: 아이가 식사 중 입을 벌리고 씹으면 무례함이 아닌 구강 호흡 문제 - 호흡기 평가 필요

5) 구강 궤양 (Oral ulcerations)

- 치약의 SLS(sodium lauryl sulfate): 구강 점막 자극, 재발성 구강 궤양 유발
- 장 질환 신호: 셀리악병, 크론병, 글루텐 불내성의 구강 증상
- 영양결핍: B12, 철분, 아연, 엽산 결핍 시 구강 궤양

3. 구강 이상균총과 장 건강

우리는 하루 약 2,000회 침을 삼킵니다. 구강에서 증식한 유해균은 이 과정을 통해 계속 장으로 유입됩니다. 구강 이상균총은 장 미생물총에 직접 영향을 미치며, 구강 내 유해균(치주병 원인균 등)이 대장 암, 심장 질환, 당뇨와 연관됨이 밝혀졌습니다.

4. 재활 팀 접근

구강-소화 문제는 다학제 접근이 필요합니다:

- 치과 의사: 치아/교합 교정, 치주 치료, 보철
- 근기능 치료사(Myofunctional therapist): 혀/입술/호흡 근기능 재훈련
- 물리치료사: 호흡 재교육, 자세 교정
- 두개천골 치료사/카이로프랙터: 구조적 제한 해제
- 귀코목 전문의(ENT): 비중격만곡, 아데노이드, 알레르기 치료